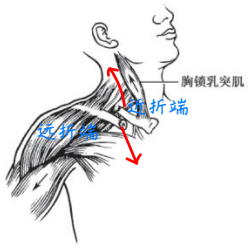
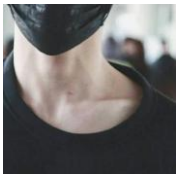
一、上肢骨折和关节脱位

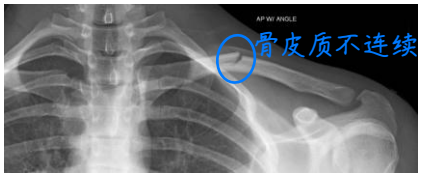
（一）锁骨骨折





1.好发部位：锁骨中 1/3





2.中 1/3 骨折的移位：近折端向上后（胸锁乳突肌牵拉）、远折端向下前移位（胸大肌牵拉）

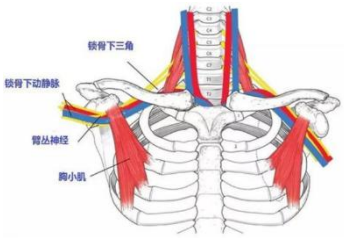
肌肉牵拉

3.临床表现

减轻重力、肌肉牵引，放松肌肉

①胸骨柄至患侧肩峰连线有隆起和压痛，健手托住患侧肘部、头向患侧倾斜

②可损伤肺、锁骨下血管、臂丛神经



4.治疗（三八线）

骨皮质是连续的，没有完全断掉

①儿童青枝、成人无移位的骨折：三角巾悬吊

②中段骨折有移位：手法复位+横形 8 字绷带外固定



图 61-2　锁骨骨折手法复位后横形“8”字绷带固定

骨折治疗大原则：
复位：①手法复位（规律）②切开复位（特殊）
固定：①外固定（与手法复位搭配）②内固定（与切开复位搭配）
功能锻炼：固定牢靠的情况下尽早锻炼

（二）肩关节脱位（盂肱关节脱位）

1.前脱位多见（jian-qian）规律：一般关节脱位多以后脱位多见

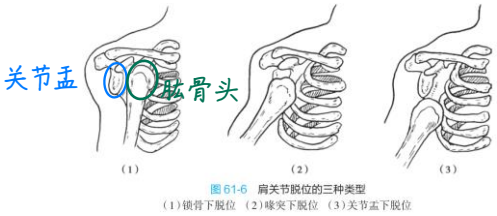
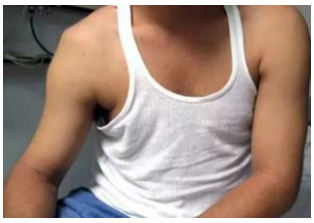


图 61-6　肩关节脱位的三种类型
（1）锁骨下脱位　（2）喙突下脱位　（3）关节盂下脱位





肱骨头（圆）　支配三角肌

2.临床表现

见于：①肩关节脱位②腋神经损伤

①弹性固定（关节脱位的特征），方肩畸形、肩胛盂 ttsx 空虚感，**健手托住患侧前臂、头向患侧倾斜**

②**Dugas** 征（监督）：在肘部紧贴胸壁时手掌搭不到健侧肩部；若手掌搭在健侧肩部则肘部不能紧贴患侧胸壁

肱骨头离开关节盂

③可合并肱骨大结节撕脱骨折、上肢神经血管损伤

VS骨折：异常活动、局部畸形、骨擦音、骨擦感

3.治疗

①前脱位：**Hippocrates 足蹬法**（Dugas 征转为阴性提示手法复位成功）+**三角巾悬吊外固定 3 周**

（若关节囊破损明显→**搭肩位胸肱绷带固定**）你是我的神　VS肩周炎不能用三角巾悬吊，需每日做肩关节主动活动

②后脱位：手术

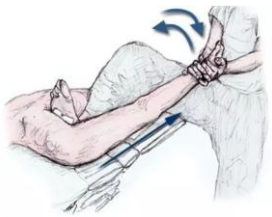




图 61-8　肩关节前脱位的 Hippocrates 复位法



图 61-9　肩关节脱位复位后外固定法



你是我的神